

Información Paciente

Nombre : Eva Soledad Cortes Leyton
Edad : 56a 0m 10d
Dirección : Los Trovadores 661

Rut : 11.479.994-7
Fecha Nacto: 09/12/1968
Comuna : Maipu

N° Archivo : 2410893
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 7132 2087

N° Epicrisis
424475

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Medicina Cuidados Básicos 5° Piso
Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 05/11/2024 14:13
Fecha Egreso : 19/12/2024 01:12

Días Estadía: 44

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Obstrucción intestinal

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICRISIS
RUT 11479994-7
FI HSR: 05/11/2024
FI SALA: 07/11/2024
FI UTIM: 08/11/2024
FI UCI: 24/11/2025

Antecedentes Patológicos:

-DHC Child C MeldNa 27 etiología HAI, Trombosis de Vena Porta (12/19) sin TACO (por HDA variceal), HDA variceal, gastropatía de HTP, ascitis y PBE en profilaxis 2°; ingresa el 05/11 al SU-HSR por cuadro de 2 semanas de evolución caracterizado por vómitos biliosos y dolor abdominal en epigastrio. Consultó en una primera instancia en Hospital del Carmen donde se habría diagnosticado obstrucción intestinal alta parcialmente ocluida, ocasión en la cual pide la alta voluntaria. Por persistencia de síntomas reconsulta en SU-HSR donde se le indica tratamiento sintomático con parcial respuesta.

Al ingreso destacan signos vitales normales salvo sat 90% ambiental, pero con buena mecánica ventilatoria.

TAC TAP c/c 13/11 que informa:

Cambios morfológicos de daño hepático crónico con desarrollo de circulación colateral portosistémica, esplenomegalia y ascitis como marcadores de hipertensión portal.

Trombosis de la vena porta principal de aspecto crónico que se extiende a rama intrahepática derecha, sin cambios significativos respecto a estudio previo.

Leve engrosamiento septal interlobulillar liso asociado a tenues opacidades pulmonares peribroncovasculares que predominan en el lóbulo superior derecho, hallazgo probablemente en contexto de edema intersticial y alveolar. Pequeños focos neumónicos de etiología inflamatoria-infecciosa sobreagregados pudiesen tener similar morfología. Correlacionar con antecedentes clínicos.

Leve a moderado derrame pleural bilateral con atelectasia parcial de ambos lóbulos inferiores.

En este contexto deciden iniciar proquinético, antibióticos y hospitalizar para continuar manejo. Evaluada por Equipo de Cirugía, quienes desestiman íleo mecánico por lo que se maneja como íleo adinámico con mala tolerancia oral y compromiso cualicuantitativo de conciencia caracterizado como EH II. En ese contexto se define con Especialidad inicio de terlipresina y

Fecha Epicrisis : 19/12/2024 01:07

evaluación por ANI para manejo de íleo y optimizar aporte nutricional por eventual trasplante. Posteriormente es evaluada por equipo de Hepatología, quienes refieren anatomía compleja dado cavernomatosis portal y compromiso importante de drenaje venoso esplénico y portal, probable causa de sus síntomas. De alto riesgo en caso de cirugía, por lo que el 19/11 por Radiología Intervencional instala TIPS (gradiente pre 17 mmHg, gradiente post 6 mm Hg) y recanalización portal, evolucionando de mala manera desde el punto de vista de conciencia (es conocido que los TIPS tienen el efecto secundario de aumentar la EH), estando varios días comprometida de conciencia y conectada a VMNI. El día 23/11 se decide manejo avanzado de VA con 3 intentos frustrados de intubación, lográndolo en un 4 intento un segundo operador con ayuda de Bougie proteger VA; refieren que se decidió SRI por mala mecánica ventilatoria, compromiso de conciencia y mal acople a VMNI

El 19/11 intercorre con shock séptico por lo que se toma hemocultivos periféricos y paracentesis diagnóstica (sin microbiología aislada de momento), se indica tratamiento antibiótico de amplio espectro.

DIAGNOSTICOS UPC:

DIAGNÓSTICOS:

1. Fungemia persistente por C. Glabrata
 - 1.1 Masa hipocogénica hipermóvil 49 mm longitud 11 mm diámetro adherido a CVC
2. Shock séptico con FMO (bacteriemia por E faecium, Klebsiella BLEE NDM)
 - 2.1 AKI KDIGO III en TRR
3. DHC por HAI Child C / Meld-Na 27 / CLIF-C 60 puntos
 - 3.1 EH grado IV
 - 3.2 Colopatía portal - TIPS 19/11
 - 3.3 Coagulopatía y pancitopenia
4. Íleo médico de difícil manejo
5. Insuficiencia respiratoria aguda
 - 5.1 EPA
 - 3.2 Derrame pleural bilateral
6. Miasis

ANTECEDENTES: DHC Child C MeldNa 27 etiología HAI, en espera de THO, TVPorta (12/19) sin TACO (por HDA variceal), HDA variceal 2 episodios erradicadas, gastropatía de HTP, ascitis y PBE

Durante su estadía en UPC paciente con fungemia persistente, evoluciona con shock refractario que requiere cambio de ATB ajustado a microbiología y susceptibilidad, como parte de estudio de fungemia se solicita ETE que informa trombo en aurícula derecha evaluado por servicio de cardiocirugía fuera de alcance quirúrgico, en este contexto sin posibilidad de anticoagulación y trasplante con pronóstico ominoso.

Se define manejo proporcional dado futilidad de tratamiento.

Paciente evoluciona con hipotensión sostenida, en malas condiciones generales. Familiares al tanto de la condición, favoreciendo acompañamiento. Paciente fallece el 19/12/2024 a las 00:45. Se notifica a familiares.

Diagnóstico de Egreso

Choque séptico -
Daño Hepático Crónico -

Condición de Egreso

Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Plan Post Alta

Paciente fallece a las 00:45 horas

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Fecha Epicrisis : 19/12/2024 01:07



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 19-12-2024 1:07:24

Página 3 de 3

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente

Raymundo Rojas Araya

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 19/12/2024 01:07

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:42

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar